OCLUSIÓN INTESTINAL

Causa más común de oclusión de intestino delgado

OCLUSIÓN INTESTINAL

Causa más común de oclusión de colon

OCLUSIÓN INTESTINAL

Radiografía de oclusión intestinal

OCLUSIÓN INTESTINAL

Datos de estrangulación

COLECISTITIS

Estudio de elección en patología vesicular

COLECISTITIS

Signo de Murphy

COLECISTITIS

Tratamiento de la colecistitis aguda

COLECISTITIS

Factores de riesgo clásicos de litiasis

RESPUESTA · OCLUSIÓN INTESTINAL

Cáncer colorrectal.

RESPUESTA · OCLUSIÓN INTESTINAL

Adherencias (bridas) posquirúrgicas.

RESPUESTA · OCLUSIÓN INTESTINAL

Fiebre, taquicardia, dolor continuo, peritonitis, leucocitosis, lactato elevado.

RESPUESTA · OCLUSIÓN INTESTINAL

Asas dilatadas con niveles hidroaéreos en escalera.

RESPUESTA · COLECISTITIS

Detención de la inspiración por dolor al palpar el hipocondrio derecho.

RESPUESTA · COLECISTITIS

Ultrasonido de hígado y vías biliares.

RESPUESTA · COLECISTITIS

Mujer, cuarentona, obesa, fértil (multípara).

RESPUESTA · COLECISTITIS

Colecistectomía laparoscópica temprana (< 72 h).

COMPLICACIONES BILIARES

Tríada de Charcot

COMPLICACIONES BILIARES

Péntada de Reynolds

COMPLICACIONES BILIARES

Tratamiento de la coledocolitiasis

COMPLICACIONES BILIARES

Tríada de Rigler (íleo biliar)

HERNIAS INGUINALES

Hernia más común en hombres y mujeres

HERNIAS INGUINALES

Límites del triángulo de Hesselbach

HERNIAS INGUINALES

Hernia con mayor riesgo de estrangulación

HERNIAS INGUINALES

Técnica abierta sin tensión más usada

RESPUESTA · COMPLICACIONES BILIARES

Charcot + hipotensión + alteración del estado mental.

RESPUESTA · COMPLICACIONES BILIARES

Fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho.

RESPUESTA · COMPLICACIONES BILIARES

Neumobilia, oclusión intestinal y lito ectópico.

RESPUESTA · COMPLICACIONES BILIARES

CPRE con extracción del lito y después colecistectomía.

RESPUESTA · HERNIAS INGUINALES

Vasos epigástricos inferiores, borde del recto y ligamento inguinal.

RESPUESTA · HERNIAS INGUINALES

Inguinal indirecta.

RESPUESTA · HERNIAS INGUINALES

Lichtenstein (con malla).

RESPUESTA · HERNIAS INGUINALES

Femoral.

HERNIAS VENTRALES

Hernia de Richter

HERNIAS VENTRALES

Hernia de Littré

HERNIAS VENTRALES

Signo de Howship-Romberg

HERNIAS VENTRALES

Hernia umbilical en niños: conducta

VÓLVULO

Vólvulo de colon más frecuente

VÓLVULO

Signo radiográfico del vólvulo de sigmoides

VÓLVULO

Tratamiento inicial del vólvulo de sigmoides sin isquemia

VÓLVULO

Tratamiento del vólvulo de ciego

RESPUESTA · HERNIAS VENTRALES

Contiene un divertículo de Meckel.

RESPUESTA · HERNIAS VENTRALES

Atrapamiento parcial de la pared antimesentérica; puede estrangularse sin oclusión.

RESPUESTA · HERNIAS VENTRALES

Observación; la mayoría cierra antes de los 4–5 años.

RESPUESTA · HERNIAS VENTRALES

Dolor en la cara interna del muslo por hernia obturatriz.

RESPUESTA · VÓLVULO

Grano de café (U invertida).

RESPUESTA · VÓLVULO

Sigmoides.

RESPUESTA · VÓLVULO

Cirugía (hemicolectomía derecha).

RESPUESTA · VÓLVULO

Destorsión endoscópica, luego sigmoidectomía electiva.

APENDICITIS

Escala de Alvarado: puntaje de alta probabilidad

APENDICITIS

Signo de Rovsing

APENDICITIS

Causa de obstrucción apendicular en niños

APENDICITIS

Imagen en embarazada con sospecha de apendicitis

DIVERTICULITIS

Estudio de elección en diverticulitis

DIVERTICULITIS

Localización más común en occidente

DIVERTICULITIS

Hinchey III y IV

DIVERTICULITIS

¿Cuándo hacer colonoscopia?

RESPUESTA · APENDICITIS

Dolor en FID al presionar la fosa iliaca izquierda.

RESPUESTA · APENDICITIS

7 o más (de 10).

RESPUESTA · APENDICITIS

Ultrasonido (resonancia si no es concluyente).

RESPUESTA · APENDICITIS

Hiperplasia linfoide.

RESPUESTA · DIVERTICULITIS

Colon sigmoides.

RESPUESTA · DIVERTICULITIS

Tomografía de abdomen con contraste.

RESPUESTA · DIVERTICULITIS

6–8 semanas después del episodio agudo.

RESPUESTA · DIVERTICULITIS

Peritonitis purulenta (III) y fecal (IV): cirugía urgente.

HEMORROIDES

Hemorroides grado III

HEMORROIDES

Tratamiento de hemorroides internas grado I–II

HEMORROIDES

Hemorroide externa trombosada < 72 h

HEMORROIDES

Diferencia clínica interna vs externa

FÍSTULA PERIANAL

Regla de Goodsall

FÍSTULA PERIANAL

Fístula perianal más común (Parks)

FÍSTULA PERIANAL

Tratamiento de la fístula baja

FÍSTULA PERIANAL

Fístulas perianales complejas: descartar...

RESPUESTA · HEMORROIDES

Fibra + ligadura con banda elástica.

RESPUESTA · HEMORROIDES

Prolapsan y requieren reducción manual.

RESPUESTA · HEMORROIDES

Interna: indolora y sangra. Externa: dolorosa.

RESPUESTA · HEMORROIDES

Escisión del trombo.

RESPUESTA · FÍSTULA PERIANAL

Interesfintérica.

RESPUESTA · FÍSTULA PERIANAL

Orificio posterior: trayecto curvo a la línea media posterior. Anterior: recto y radial.

RESPUESTA · FÍSTULA PERIANAL

Enfermedad de Crohn.

RESPUESTA · FÍSTULA PERIANAL

Fistulotomía.

ABSCESO PERIANAL

Origen del absceso perianal

ABSCESO PERIANAL

Tratamiento del absceso perianal

ABSCESO PERIANAL

¿Cuándo agregar antibióticos?

ABSCESO PERIANAL

Evolución crónica del absceso

FISURA ANAL

Localización más común de la fisura anal

FISURA ANAL

Tríada de la fisura crónica

FISURA ANAL

Tratamiento médico de la fisura

FISURA ANAL

Cirugía de la fisura crónica refractaria

RESPUESTA · ABSCESO PERIANAL

Incisión y drenaje inmediatos.

RESPUESTA · ABSCESO PERIANAL

Infección de las glándulas anales (criptoglandular).

RESPUESTA · ABSCESO PERIANAL

Fístula perianal (30–50 %).

RESPUESTA · ABSCESO PERIANAL

Celulitis extensa, inmunosupresión, diabetes, valvulopatía o sepsis.

RESPUESTA · FISURA ANAL

Úlcera, papila hipertrófica y hemorroide centinela.

RESPUESTA · FISURA ANAL

Línea media posterior.

RESPUESTA · FISURA ANAL

Esfinterotomía lateral interna.

RESPUESTA · FISURA ANAL

Fibra, baños de asiento y relajantes del esfínter (nifedipino/diltiazem tópico).

ÚLCERAS POR PRESIÓN

Sitio más común de úlcera por presión

ÚLCERAS POR PRESIÓN

Escala para evaluar el riesgo

ÚLCERAS POR PRESIÓN

Úlcera estadio 4

ÚLCERAS POR PRESIÓN

Frecuencia de cambios de posición

ENFERMEDAD ARTERIAL

ITB diagnóstico de enfermedad arterial periférica

ENFERMEDAD ARTERIAL

Factor de riesgo más importante de EAP

ENFERMEDAD ARTERIAL

Fármaco para mejorar la distancia de claudicación

ENFERMEDAD ARTERIAL

Las 6 P de la isquemia aguda

RESPUESTA · ÚLCERAS POR PRESIÓN

Braden (menor puntaje, mayor riesgo).

RESPUESTA · ÚLCERAS POR PRESIÓN

Región sacra.

RESPUESTA · ÚLCERAS POR PRESIÓN

Cada 2 horas.

RESPUESTA · ÚLCERAS POR PRESIÓN

Pérdida total con exposición de músculo, tendón o hueso.

RESPUESTA · ENFERMEDAD ARTERIAL

Tabaquismo.

RESPUESTA · ENFERMEDAD ARTERIAL

< 0.9.

RESPUESTA · ENFERMEDAD ARTERIAL

Dolor, palidez, ausencia de pulso, parestesias, parálisis y frialdad.

RESPUESTA · ENFERMEDAD ARTERIAL

Cilostazol.

INSUFICIENCIA VENOSA

Estudio de elección en insuficiencia venosa

INSUFICIENCIA VENOSA

CEAP C6

INSUFICIENCIA VENOSA

Localización típica de la úlcera venosa

INSUFICIENCIA VENOSA

Base del tratamiento

QUEMADURAS

Fórmula de Parkland

QUEMADURAS

Regla de los 9: una pierna completa

QUEMADURAS

Meta de diuresis en adulto quemado

QUEMADURAS

Quemadura de espesor total

RESPUESTA · INSUFICIENCIA VENOSA

Úlcera venosa activa.

RESPUESTA · INSUFICIENCIA VENOSA

Ultrasonido Doppler venoso.

RESPUESTA · INSUFICIENCIA VENOSA

Compresión graduada.

RESPUESTA · INSUFICIENCIA VENOSA

Región maleolar medial.

RESPUESTA · QUEMADURAS

18 %.

RESPUESTA · QUEMADURAS

4 mL × kg × % SCQ de Ringer lactato en 24 h (mitad en las primeras 8 h).

RESPUESTA · QUEMADURAS

Acartonada, blanquecina o negra, indolora.

RESPUESTA · QUEMADURAS

0.5 mL/kg/h.